Cas polypathologique M3

Rapport synthétique

Cas clinique :
Patient de 79ans est hospitalisé pour décompensation cardiaque avec fraction d'éjection conservée à 66%, Heart Failure with preserved Ejection Fraction (HFpEF) à la suite de l'administration de la première dose d'Azacitidine (Vidaza). Azacitidine est un agent déméthylant de l'ADN prescrit dans le cadre d'une leucémie myéloïde aiguë.

Antécédents médicaux pertinents :
- Diabète de type 2
- Syndrome métabolique
- Cardiopathie hypertensive avec dysfonction diastolique franche de grade 2
- Dermo-hypodermite au niveau prétibial gauche.
- Fibrillation atriale
- Infarctus du myocarde
- BPCO GOLD II
- Leucémie myéloïde aiguë

Antécédents chirurgicaux pertinents :
- Mise en place d'un Pacemaker DDD

Allergies et assuétude :
- Pas d'allergie connue à ce jour.
- Tabac : 50 UPA (2paquets/j pendant 25ans) arrêté depuis une vingtaine d'années.
- Alcool : occasionnelle
- Il nie toute autre consommation.

Médication (en septembre 2026) :

!!!! cp mets en note de bas de page ce que ça veut dire, ça fait + pro idem pour inh

Dénomination Commune Internationale (DCI)	**Nom commercial & Posologie**	**Classe pharmaco-thérapeutique**	**Indication clinique**
Ézétimibe / Atorvastatine	Atozet 10 mg / 40 mg 1 cp/j	Hypolipémiant combiné (inhibiteur sélectif de l'absorption du cholestérol + statine de haute intensité)	**Prévention cardiovasculaire secondaire**
Bumétanide	Burinex 1 mg	Diurétique de l'anse de Henle	**Traitement déplétif de la surcharge hydrosodée** :

Commenté [FP1]: faut savoir ce que c'est

Commenté [FP2]: Hypothèse car l'implantation date de 2012 :
- maladie du sinus (syndrome tachycardie-bradycardie) // à FA paroxystique. => faut sécuriser le rythme pour pvr initier la bithérapie bisoprolol et cordarone.
- Trouble conductif auriculo-ventriculaire de haut degré intermittent ou paroxystique.

=> ECG réalisé élimine le BAV3 permanent (car rythme sinusal, espace PR nl, QRS fin)
=> DDD a une sonde auriculaire et ventriculaire --> ne décharge qu'au besoin en fonction de la conduction du noeud sinusal

a mis en forme

a mis en forme

Dénomination Commune Internationale (DCI)	**Nom commercial & Posologie**	**Classe pharmaco-thérapeutique**	**Indication clinique**
	1 cp/j		contrôle des pressions de remplissage ventriculaire gauche élevées liées à la cardiopathie hypertensive avec dysfonction diastolique de grade 2.
Bisoprolol	Bisoprolol 10 mg ½ cp/j *(5 mg/j)*	Bêtabloquant β_1-cardiosélectif	**Cardiopathie hypertensive & contrôle hémodynamique** : baisse des résistances vasculaires périphériques, allongement du temps de remplissage diastolique par ralentissement de la fréquence cardiaque, et freinage de l'hyperactivité sympathique.
Amiodarone	Cordarone 200 mg 1 cp/j	Antiarythmique de classe III de Vaughan-Williams	Prévention des récidives de tachyarythmie supraventriculaire
Fluticasone furoate / Uméclidinium / Vilantérol	Trelegy Ellipta 92/55/22 µg 1 inh/j	Trithérapie inhalée fixe : Corticoïde inhalé (CSI) + Anticholinergique à longue durée d'action (LAMA) + β_2-mimétique à longue durée d'action (LABA)	**Traitement de fond de la BPCO**
Bromure d'ipratropium / Fénotérol	Duovent *(posologie à la demande)*	Bronchodilatateur d'action rapide combiné : Anticholinergique à courte durée d'action (SAMA) + β_2-mimétique à courte durée d'action (SABA)	**Traitement de secours / à la demande** : levée immédiate du bronchospasme et prise en charge des accès dyspnéiques paroxystiques dans la BPCO.

Dénomination Commune Internationale (DCI)	Nom commercial & Posologie	Classe pharmaco-thérapeutique	Indication clinique
Apixaban	Eliquis 5 mg 1 cp 2x/j	Anticoagulant oral direct (AOD)	**Thromboprophylaxie systémique** liée à l'arythmie supraventriculaire associée (score CHA_2DS_2-VA élevé).
Cholécalciférol (Vitamine D3)	Vista D3 1 cp/j	Vitamine D / régulateur du métabolisme phosphocalcique	**Prévention** de l'ostéopénie/ ostéoporose
Zolpidem	Stilnox 10 mg 1 cp le soir	Hypnotique apparenté aux benzodiazépines	**Traitement symptomatique de courte durée de l'insomnie d'endormissement**.
Azacitidine	Vidaza cure palliative par voie sous-cutanée : 7jours/mois pendant 28jours	Agent déméthylant	**Traitement de la leucémie myéloïde aiguë non éligible à une chimiothérapie d'induction intensive**
Dapagliflozine	Forxiga10 mg 1 cp/j	Inhibiteur SGLT2	**Triple indication :** - **Diabète de type 2** - **Cardioprotection** - **Néphroprotection**
Oxygénothérapie chronique	2L/min par oxyconcentrateur		**Support pour l'hypoxémie nocturne et les troubles de diffusion dans le cadre de la BPCO**

Commenté [FP3]:
Critères et pondération du score CHA_2DS_2-VA

Lettre → Critère clinique → Points
C → Congestive heart failure (Insuffisance cardiaque / dysfonction VG) → +1
H → Hypertension artérielle → +1
A_2 → Âge ≥ 75 ans → +2
D → Diabète (type 1 ou 2) → +1
S_2 → Stroke / AVC, AIT ou antécédent thromboembolique → +2
V → Maladie vasculaire (infarctus du myocarde, AOMI, plaque aortique) → +1
A → Âge entre 65 et 74 ans → +1

Commenté [FP4]: Zolpidem a courte durée d'action et sédatif => induit le sommeil

Commenté [FP5]: il n'y a aps de notion d'IR mais toujours bien de protéger les reins vu le contexte ?

Contexte psycho social :
Le patient vit au domicile avec son épouse. Elle est très présente pour le patient. Le patient a 2 enfants et 4 petits-enfants.
Le patient se sent très limité, dyspnéique et trouve le temps long en chambre. Une thymie triste domine dans le discours du patient.

Histoire clinique :

Le patient est hospitalisé dans le service d'onco-hématologie pour insuffisance respiratoire de type I sur décompensation cardiaque. Suite à l'administration de la première dose d'Azacitidine (Vidaza)